

24 - 02- Les Retards de Croissance Intra Utérin (RCIU) - Pr. N. El Idrissi Slitine

(0:00 - 0:16)

Bonjour. Les cours sur les retards de croissance intra-utérin sont un enchaînement du cours sur la prématurité. Nous allons voir qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont similaires et donc nous allons passer rapidement sur ces aspects-là.

(0:17 - 0:26)

Tout d'abord, quelques définitions. L'hypothrophie fœtale est une insuffisance de poids par rapport à la gestation lèvre. C'est une mesure qui est ponctuelle.

(0:26 - 0:45)

Le retard de croissance intra-utérin est un développement insuffisant du fœtus pour son âge gestationnel. Le retard de croissance intra-utérin est dit quand le poids est inférieur au dixième percentile des cours de référence pour la gestation lèvre. L'hypothrophie est fréquente.

(0:46 - 1:11)

Le retard de croissance intra-utérin constitue 30% des hypothrophies. Quand les trois mensurations sont diminuées, le poids, taille ainsi que le périmètre crânien, le retard de croissance intra-utérin est dit harmonieux et représente 30% des cas. Si seul le poids est diminué, le retard de croissance est dit disharmonieux et c'est 70% des situations.

(1:15 - 1:36)

Plusieurs causes sont responsables de retard de croissance intra-utérin. D'abord les causes maternelles telles que l'HTA gravidique, les syndromes vasculaires et longs, le tabagisme, l'alcool, les maladies maternelles chroniques. L'étiologie la plus fréquente est l'HTA gravidique et elle représente 30% des cas.

(1:37 - 1:58)

A côté des causes maternelles il y a les causes placentaires. On observe les petits placentas, l'insertion prévia et les troubles ischémiques placentaires. Également les causes fœtales sont responsables de RCI, les infections virales telles que le CMV, la ribéole.

(1:59 - 2:18)

Il y a les aberrations chromosomiques telles que les trisomies. Il y a les grossesses multiples qui s'observent dans le cadre du syndrome transfuseur-transfusé en cas de grossesse gémellaire monocoriale biomimotique. Dans 30% des cas aucune étiologie n'est retrouvée.

(2:21 - 2:40)

Pour faire le diagnostic d'un retard de croissance intra-utérin il faut connaître au préalable l'âge gestationnel avec précision. Et donc la datation avant la naissance est la même par rapport au prématuré. On doit connaître l'âge des dernières règles mais à condition que le cycle soit régulier.

(2:40 - 3:26)

On peut connaître la courbe ménométrique, on connaît exactement le jour du rapport fécondant ou bien par l'intermédiaire de l'échographie océfricale précoce qui est la plus précise pour la datation de l'âge gestationnel entre la 10^e et la 14^e semaine d'année norée. Le diagnostic du retard de croissance au cours de la grossesse peut se faire par la prise de la mesure de la hauteur utérine. En hétéro, il peut se faire par les mensurations échographiques à savoir le diamètre abdominal transverse, la longueur du fémur et le diamètre biparietal.

(3:29 - 4:00)

Une fois que nous sommes devant un retard de croissance intra-utérin, il faut rapidement connaître la conduite à tenir à prendre. Première des choses, rechercher et traiter la cause du RCI quand elle est traitable. Parmi ces causes-là, l'hypertension artérielle gravidique, l'intoxication tabagique, faire un caryotype fœtal si le retard de croissance est précoce et sévère sans cause évidente et rechercher une cause fœtale.

(4:01 - 4:24)

Il faut également apprécier la gravité de la souffrance fœtale chronique. Cette gravité est en fonction de l'éthiologie, du niveau de l'évolutivité des mensurations fœtales et puis en fonction aussi des Dopplers utérins, ombilicales et cérébrales. Il faut également faire un enregistrement du rythme cardiaque fœtale.

(4:24 - 4:51)

En présence d'un rythme sinusoidal, d'un ralentissement du rythme cardiaque fœtale ou d'un rythme plat, la situation est gravissime et le bébé est en danger. Le score de manie est un score qui évalue la viabilité du bébé. Très important, le fait d'apprécier la maturité fœtale car elle conditionne la date d'extraction du nouveau-né.

(4:51 - 5:15)

Faut-il l'extraire à terme ou bien même avant son terme ? A la naissance, deux formes cliniques sont individualisées. Le retard de croissance harmonieux et le retard de croissance disharmonieux, où seul le poids est inférieur au dixième percentile. Et où le bébé a l'aspect d'un fœtus araignée.

(5:15 - 5:51)

C'est un nouveau-né qui est maigre, qui a la peau sèche, qui n'a pas de panique radicale, qui est agité, affamé, avec les yeux qui sont grand ouverts. La même chose que pour le prématuré, nous faisons la datation en l'absence de connaissances précises de la date des dernières règles de l'âge gestationnel. Nous pouvons faire la datation après la naissance et le score de phare ainsi que le score de balard sont très importants pour étudier l'âge gestationnel.

(5:52 - 6:23)

Une fois la datation est faite, nous allons prendre ces mensurations et les mettre dans le tableau des courbes de référence, poids, périmètre crânien et taille. Il est très important d'anticiper et de traiter les complications qui peuvent survenir chez le nouveau-né lors du retard de croissance intra-hétéra. Parmi ces complications les plus fréquentes sont l'asphyxie périnatale.

(6:23 - 6:43)

Un risque très élevé chez les retards de croissance de faire l'asphyxie périnatale. Également, il peut faire une hypothermie. Il se complique d'hypoglycémie, d'où l'intérêt d'une alimentation précoce afin de prévenir ces hypoglycémies.

(6:44 - 7:06)

Ou bien, dans le cas d'une hospitalisation, il faut le perfuser et lui apporter du glucosé par voie intraveineuse. Le retard de croissance intra-hétéra peut faire aussi des hypocalcémies. Des polyglobulins sont diagnostiqués par un taux d'hématocrite qui est supérieur à 65% chez le nouveau-né.

(7:07 - 7:23)

Le retard de croissance fait des thrombopénioses, des insuffisances rénales aiguës et une écrose tubulaire aiguë. Quant au devenir et au pronostic, le nouveau-né atteint le retard de croissance intra-hétéra. Il dépendra de plusieurs facteurs.

(7:23 - 7:35)

1. La cause du retard de croissance intra-hétéra. 2. La date du début du retard de croissance. 3. Les formes précoces avant 34 semaines sont de pronostics moins bons par rapport aux formes tardives.

(7:37 - 8:05)

4. Le type de retard de croissance intra-hétéra. 5. Les formes harmonieuses sont de pronostics plus fâcheux par rapport aux formes disharmonieuses, dont les formes disharmonieuses, le

pronostic, le périmètre crânien et le cancer. Et puis, quand on a un retard de croissance associé à une prématurité, nous avons en plus de la morbidité associée au retard de croissance, la morbidité liée à la prématurité.

(8:08 - 8:33)

Ceci est une courbe montrant la morbidité et la mortalité dans son évolution chez le nouveau-né ayant un retard de croissance intra-hétéra. Et on voit que plus l'âge gestationnel est bas, plus la morbidité et la mortalité sont aigus. Concernant la croissance post-natale des retards de croissance intra-hétéra, il y a un rattrapage qui s'observe en général dans la première année de vie.

(8:34 - 8:59)

Cependant, dans le tiers des cas, et surtout dans les retards de croissance intra-hétéra qui sont idiopathiques, nous n'observons pas ce rattrapage jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Ici, c'est l'indication de l'hormone de croissance. La croissance du périmètre crânien et l'importance d'un micro-circadique sont des éléments essentiels pour établir les pronostics de ces nouveaux-nés avec retard de croissance intra-hétéra.

(9:01 - 9:36)

Le devenir à moyen terme est caractérisé par des conséquences neuro-comportementales caractérisées par une hyperactivité, un déficit de l'attention ou des difficultés scolaires. A long terme, c'est-à-dire à l'âge adulte, il y a des risques très importants d'hypertension artérielle, d'accidents coronariens, de diabète insulino-résistant et de dyslipidémie. En conclusion, il est très important de suivre les grossesses car à travers ce suivi, nous pouvons au moins connaître l'âge gestationnel précisément.

(9:37 - 10:17)

Les mesures anthropométriques, à savoir le périmètre crânien, la taille et le poids, sont très importants à prendre car ils permettent de mettre des bébés sur les courbes de référence et de suivre leur croissance. L'examen du placenta à lui seul permet de nous orienter vers d'importantes écologies concernant le retard de croissance intra-hétéra. Et enfin, le suivi de ces enfants ayant présenté un retard de croissance intra-hétéra est crucial car il nous permettra d'intervenir à temps dans leur croissance à l'âge de 3-4 ans et même à l'âge adulte.

(10:18 - 10:19)

Je vous remercie.